Prendre en charge une atteinte circonstancielle

1er regard → 2ème regard → 2ème regard → 4ème regard

Syndrome de suspension — OPT

1 **Dégager si possible** rapidement et en sécurité
- **Essayer de maintenir l'horizontalité** si la victime est suspendue

2 **Desserrer le harnais + Lutter contre l'hypothermie,** si la victime est consciente après le décrochage

Victime d'avalanche — OPT

1 **Appliquer les conduites à tenir** de l'asphixie + du traumatisme + de l'hypothermie

4 **Noter les heures** d'ensevelissement et de dégagement

Accidents liés à la foudre — OPT

1 **Analyser le mécanisme**
- Direct : tombée sur la victime ou propagation par contact
- Indirect : point de contact ou tension de pas

1 **Se protéger** (casque, petit pas, s'éloigner, 3 mètres, éviter les clairières)

1 **Prévenir les accidents :**
- en montagne : cône de protection
- en grotte : s'éloigner de l'entrée
- si risque élevé : position en boule sur sac ou corde
- éloigner les matières conductrices

Hypothermie — PSE2

2 **Lors de la réanimation,** mesurer la température et limiter à 3 chocs
- **Si légère, réchauffer**
- **Si modérée ou sévère, réchauffer et mettre l'oxygène**

Gelures — PSE2

1er degré : localisée rouge, insensible, sans cloque
2e degré : localisée rouge, insensible, oedeme, cloques claires
3e degré : insensible, bleuté/noirâtre, insensibilité persistante, cloque sanguinolante, risque d'amputation
4e degré : insensible, bleuté, extensive, les tissus restent froids malgré le réchauffement et peuvent devenir nécrotiques, persistance de l'insensibilité = amputation inévitable

4 Gelures mineures : **sécher sans frictionner, réchauffer 10 min** les extrémités **au contact de la peau** du sauveteur

4 Gelures sévères et graves < 24h : **immerger 20 à 30 min** les atteintes **dans l'eau (37 à 39°)** – Pas de chaleur sèche ou supérieure à 39°

Pendaison, Strangulation — OPT

1 **Soutenir la victime**
Desserrer le lien
- **Allonger** en limitant les mouvements du rachis

4 **Immobiliser si nécessaire**

Victimes d'explosion — PSE2

1 **Regrouper toutes les victimes**
- **Primaire :** onde de choc
- **Secondaire :** projection de matériaux
- **Tertiaire** : projection de la victime
- **Quaternaire** : brûlures externes et internes (fumées ou produits)

Compression de membres — PSE2

1 2 **Evaluer la durée de compression**
Placer un garrot et dégager, si avis médical impossible et durée de compression supérieure à 4h

Accident électrique — PSE2

1 **Sécuriser la zone**
Ne pas sortir d'un véhicule exposé

4 **Rechercher des lésions** par contraction musculaire ou traumatique (projections)

Accidents liés à la plongée — PSE2

1 **Déséquiper →Déshabiller → Sécher →Réchauffer**

2 **Mettre sous oxygène à 15 l/min** peu importe la saturation
- **Faire boire** de 0,5 à 1 litre d'eau plate
- **Aider à prendre de l'aspirine** si le médecin le demande dans les 30 premières minutes

4 **Recueillir** les paramètres de la plongée, tables, symptômes, etc

Chaleur — PSE2

- Refroidissement passif pour tous
- Crampe : **refroidir et étirements**
- Insolation : **refroidissement actif simple**
- Coup de chaleur et hyperthermie maligne d'effort : **important refroidissement actif avancé** (plonger dans l'eau)

Accouchement inopiné — PSE1

4 **Questionner sur la grossesse**

Si l'accouchement est imminent :

4 **Procéder à l'accouchement**
Préparer les zones « maman » et « nouveau né »
- **Dégager le cordon** en présence d'un circulaire (cordon autour du cou)

Après la délivrance :

4 **Procéder ou faire procéder à un massage utérin** après la délivrance

Accouchement inopiné — PSE1

- **Clamper le cordon** après 1 minute de vie sauf urgence vitale
- **Protéger spécifiquement le nouveau né contre le froid** (éviter les courants d'air, bonnet, etc.)

2 **Adapter la réanimation**

Soin au cordon ombilical — PSE1

4 **Changer de gants**
Essuyer la zone de clampage
- **Poser le 1er clamp** (10-15 cm)
- **Pincer et vider le cordon**
- **Poser le 2nd clamp**
- **Couper le cordon**
- **Protéger l'extrémité du cordon**

Intoxications — PSE2

1 **Ingestion – Inhalation,** appliquer conduite à tenir brûlure chimique

3 **Opiacés ou opioïdes :**
Respi <12 mvt/min → Oxygène

4 Respi <6 mvt/min et > 14 ans → Naloxone par nasal (absence d'évolution ou réapparition de signes : 1 injection toutes les 3min)

Noyade — PSE2

2 **Pratiquer une RCP si nécessaire** en commençant par les compressions
- **Sécher** en frictionnant

Cette fiche met en évidence les variations en fonction du thème vis-à-vis de la procédure générale.

Aussi sur le terrain, il convient d'appliquer la procédure générale, et d'y intégrer la variation au bon regard.